

Colpocleisis (cirugía de cierre vaginal)

Información para el paciente · Una reparación de prolapso sencilla y duradera que cierra la vagina

WARWIKI

La colpocleisis es una cirugía muy eficaz y de bajo estrés para el prolapso de órganos pélvicos que funciona al **cerrar la mayor parte del canal vaginal** para sostener los órganos de forma permanente. Como cierra la vagina, la eligen personas seguras de que ya no desean tener relaciones vaginales. Es rápida, suave para el cuerpo y muy exitosa — una excelente opción, sobre todo a edades mayores o con otros problemas de salud.

Acerca de este procedimiento

En vez de reconstruir el soporte, la colpocleisis **quita una tira del revestimiento vaginal y une las paredes con puntos**, acortando y cerrando el canal para que los órganos ya no puedan caer. Se puede hacer con el útero en su lugar o tras extraerlo. Como evita una reconstrucción larga, es más rápida y de menor riesgo que otras cirugías de prolapso, con un éxito de más del **90%**.

La decisión clave

El punto esencial: tras la colpocleisis, **las relaciones vaginales ya no son posibles**, y el cambio es permanente. Para quienes están seguras de esto, la satisfacción es muy alta. Su equipo confirmará que es la opción adecuada y que no hay otras inquietudes (como la necesidad de evaluar el útero) antes de seguir.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Prolapso

Cuando los órganos pélvicos caen y causan un bulto o presión.

Colpocleisis

Cirugía que cierra la mayor parte del canal vaginal para sostener los órganos.

Cirugía obliterante

Una reparación que cierra (en vez de reconstruir) la vagina.

LeFort

Una versión de la colpocleisis hecha con el útero aún en su lugar.

Cabestrillo

Un soporte que a veces se añade a la vez para el escape de orina.

¿LE DOLERÁ? La cirugía se hace con anestesia (a menudo espinal o general), así que no siente nada durante ella, y suele ser corta. Después, la mayoría tiene solo molestias leves y se recupera rápido — una de las recuperaciones más fáciles entre las cirugías de prolapso.

Cómo prepararse

- Esté **segura de la decisión** de no tener relaciones vaginales.
- Siga sus **instrucciones de anestesia** (ayuno, suspender anticoagulantes según le indiquen).
- Una evaluación preoperatoria; a veces se **añade un cabestrillo** si también escapa orina.
- Organice transporte y algo de ayuda en casa.

Qué sucede

- 1 Está bajo anestesia; se administran antibióticos.
- 2 Se quitan tiras del revestimiento vaginal y las paredes se **unen con puntos**, cerrando el canal.
- 3 Se colocan brevemente una sonda y a veces un taponamiento vaginal.

Después de la cirugía

- A menudo estancia el **mismo día o una noche**; recuperación leve.
- Una sonda por poco tiempo; algo de manchado es normal.
- **Evite levantar peso y los esfuerzos** por varias semanas; trate el estreñimiento.

Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- Sangrado abundante
- **No puede orinar** tras retirar la sonda
- Dolor pélvico que empeora

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La colpocleisis cierra la mayor parte de la vagina para sostener el prolapso — rápida, muy duradera e ideal cuando quiere una reparación simple y de bajo riesgo.
2. El costo es permanente: **las relaciones vaginales ya no son posibles** — es para quienes están seguras de eso.
3. La recuperación suele ser fácil. Evite los esfuerzos y llame por fiebre, sangrado abundante o problemas para orinar.